ABDOMEN AGUDO I

DR. GERARDO VICTORIA

CONCEPTO DE ABDOMEN AGUDO

- No es un diagnóstico: es un síndrome tiempo-dependiente y quirúrgico en potencia.
- Puede pasar de inflamación a necrosis, perforación, sepsis y shock.
- Primera pregunta: «¿está en peligro?», no «¿qué enfermedad tiene?».

DOLOR VISCERAL

- Mal localizado, profundo, en línea media; con náuseas, sudoración y síntomas autonómicos (ej. apendicitis inicial periumbilical).

DOLOR PARIETAL

- Localizado e intenso; aumenta con el movimiento, la tos o la percusión. Indica irritación del peritoneo parietal.

DOLOR REFERIDO

- Percibido lejos del órgano por convergencia neural: hombro en irritación diafragmática, escápula en patología biliar.



¿ESTABLE O INESTABLE?

- La fisiología manda antes que la etiología.
- Inestable: hipotensión, taquicardia, alteración mental, oliguria, piel fría, lactato elevado, shock.
- En el inestable, las imágenes no deben retrasar la reanimación ni el control de foco o hemorragia.

ABCDE DEL ABDOMEN AGUDO

- Vía aérea, oxigenación, circulación (IV, fluidos, sangre, lactato), estado mental/dolor y examen completo.
- Siempre con analgesia, laboratorio e imagen dirigidos y reexamen seriado.

ULTRASONIDO

- Primera línea en hipocondrio derecho/patología biliar, embarazo/pelvis, pediatría seleccionada y AAA a pie de cama.

TC DE ABDOMEN Y PELVIS

- Alto rendimiento en obstrucción, diverticulitis, perforación, absceso, complicaciones y dolor no localizado.

ANGIO-TC

- Estudio clave ante sospecha de isquemia mesentérica o patología vascular abdominal.

POCUS

- No reemplaza la evaluación completa, pero acelera decisiones en el inestable: líquido libre, AAA, vesícula, embarazo.



APENDICITIS AGUDA

- Secuencia: obstrucción luminal → distensión → compromiso venoso → isquemia → invasión bacteriana → necrosis o perforación.
- Clínica: anorexia, dolor periumbilical que migra a FID, náuseas/vómitos y fiebre baja.
- Signos: McBurney, Rovsing, psoas y obturador.

SCORES DE APENDICITIS

- Alvarado (MANTRELS), AIR y Adult Appendicitis Score: estratifican, no reemplazan el juicio.
- Bajo riesgo: observar o descartar; intermedio: imagen; alto: cirugía o imagen confirmatoria.

ABDOMEN AGUDO I

DR. GERARDO VICTORIA

CLASIFICACIÓN SINDRÓMICA

- Inflamatorio: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis.
- Obstructivo: adherencias, hernias, tumores, vólvulo.
- Perforativo: úlcera, diverticulitis, tumor, iatrogenia.
- Vascular: isquemia mesentérica, trombosis, AAA roto.
- Hemorrágico: hemoperitoneo, ectópico, trauma, aneurisma.
- Extraabdominal: IAM, neumonía basal, cetoacidosis, zóster.

MIGRACIÓN DEL DOLOR

- Periumbilical (visceral inicial) → FID (peritoneo parietal) → generalizado (perforación/peritonitis).
- La cronología importa más que una lista de síntomas.

BANDERAS ROJAS

- Hipotensión o shock, peritonitis generalizada, dolor desproporcionado al examen, lactato elevado o acidosis.
- Neumoperitoneo, asa cerrada, déficit perfusional intestinal en la TC.
- Anciano o inmunosuprimido con examen poco expresivo.
- Conducta: reanimar, avisar a cirugía y controlar el foco sin retrasos.

LABORATORIO

- Básicos: hemograma, electrolitos, función renal, glucosa, pruebas hepáticas, bilirrubina, orina.
- Según sospecha: lipasa, lactato, gasometría, coagulación, hemocultivos, grupo y reserva, β-hCG.
- Leucocitos normales no excluyen enfermedad grave en ancianos e inmunosuprimidos.

ANALGESIA EN EL ABDOMEN AGUDO

- Mito: «no dar analgesia porque enmascara el abdomen quirúrgico».
- Práctica moderna: analgesia apropiada, documentar el examen y reevaluar de forma seriada.

CINCO ERRORES PELIGROSOS

- Esperar leucocitosis para creer en enfermedad grave.
- Negar analgesia hasta que «lo vea cirugía».
- Pedir TC antes de reconocer shock o peritonitis.
- Descartar isquemia por abdomen blando.
- Retrasar el control de foco por un dato menor.

TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS

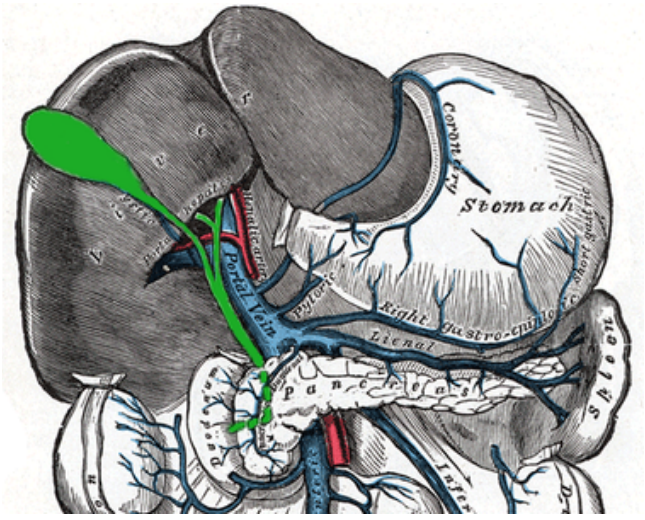
- No complicada: apendicectomía laparoscópica, tratamiento definitivo estándar; antibióticos en pacientes seleccionados.
- Complicada (perforación, absceso, flemón, peritonitis): antibióticos y control de foco con cirugía o drenaje.
- El manejo conservador implica selección, vigilancia y plan ante deterioro.

COLECISTITIS AGUDA CALCULOSA

- Clínica: dolor en HCD o epigastrio, fiebre, Murphy, leucocitosis o PCR elevada.
- Ultrasonido: cálculos, pared engrosada, distensión, líquido perivesicular, Murphy sonográfico.
- Colecistectomía laparoscópica temprana; drenaje percutáneo en no candidatos.

LA VESÍCULA DIFÍCIL

- Critical view of safety: despejar el triángulo hepatocístico y ver solo dos estructuras entrando a la vesícula.
- Si no se logra (bail-out): colangiografía, conversión, colecistectomía subtotal o drenaje.
- Una lesión de vía biliar es peor que una subtotal bien indicada.



ANTIBIÓTICOS EN ABDOMEN AGUDO

- Sí: infección intraabdominal complicada, perforación, sepsis, apendicitis complicada, colecistitis infectada, colangitis, diverticulitis complicada.
- No necesariamente: pancreatitis estéril, diverticulitis leve no complicada seleccionada.
- Elegir según foco, gravedad, flora y resistencia local; duración corta.

ABDOMEN AGUDO I

DR. GERARDO VICTORIA

CONTROL DE FOCO

- Los antibióticos no sustituyen un foco no controlado.
- Resecar, reparar, drenar, desobstruir o desbridar.

CUÁNDO LLAMAR AL CIRUJANO

- Inestabilidad, peritonitis generalizada, neumoperitoneo, isquemia sospechada, obstrucción estrangulada o asa cerrada, hemorragia intraabdominal, AAA roto, sepsis con foco no controlado.